Nespavosť a nadmerná denná spavosť pri chronickej chorobe obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia nočného bdenia vytvorená pomocou umelej inteligencie.

Vo francúzskej kohorte CKD-REIN uvádzalo pri vstupe nespavosť 22 % pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) bez dialýzy a nadmernú dennú spavosť 15 %. Nespavosť sa spájala najmä s tým, ako veľmi pacientov trápili kŕče, svrbenie a obavy súvisiace s ochorením obličiek. Pri dennej spavosti bola najvýraznejšia súvislosť s únavou [1].

Ako sa zisťovali poruchy spánku

Prospektívna kohorta zahŕňala dospelých s CKD v štádiách G2 až G5 zo 40 nefrologických ambulancií vo Francúzsku. Pri zaradení nepodstupovali dialýzu a nemali transplantovanú obličku. Aspoň jeden dotazník vyplnilo 2 765 pacientov. Ich priemerný vek bol 67 rokov, 66 % tvorili muži a priemerná odhadovaná glomerulová filtrácia (eGFR) bola 34 ml/min/1,73 m². Dotazníky pri zaradení a po jednom, troch a piatich rokoch poskytli 7 264 pozorovaní. Autori pri analýze zohľadnili opakované merania u toho istého pacienta [1].

Za nespavosť sa považoval zle hodnotený spánok v predchádzajúcich troch mesiacoch spolu s ťažkosťami so zaspávaním, prebúdzaním počas noci alebo predčasným ranným prebudením bez opätovného zaspania aspoň trikrát týždenne. Pri nadmernej dennej spavosti sa zisťoval pocit výraznej spavosti cez deň aspoň trikrát týždenne v rovnakom období. Vstupná prevalencia dosiahla 22 % (95 % interval spoľahlivosti od 21 do 24 %) pri nespavosti a 15 % (od 14 do 16 %) pri spavosti. Tieto podiely vyjadrujú výskyt ťažkostí podľa dotazníka. Nespavosť sa neoverovala klinickým rozhovorom a spavosť sa nehodnotila Epworthovou škálou [1].

Denná spavosť, únava a funkcia obličiek

Po zohľadnení veku a pohlavia sa albuminúria štatisticky významne nespájala ani s jedným zo sledovaných príznakov. Pri nespavosti sa nepreukázala ani súvislosť s eGFR. Pri dennej spavosti bol v modeli zohľadňujúcom aj sociálne faktory, pohybovú aktivitu, pridružené ochorenia a lieky pomer šancí 1,16 (95 % interval

spoľahlivosti od 1,05 do 1,28) na každých 10 ml/min/1,73 m² nižšej eGFR. Ide o porovnanie šancí pri odlišnej eGFR. Model nevyjadruje zmenu individuálneho rizika pri poklese filtrácie v čase [1].

V plne upravenom modeli, ktorý zahŕňal aj únavu a ďalšie príznaky, sa odhad oslabil na 1,05 (95 % interval spoľahlivosti od 0,96 do 1,16). Čím viac pacientov trápila únava, tým vyššia bola šanca, že uvedú aj dennú spavosť. Súvislosť pretrvala po zohľadnení depresie, nespavosti a spánkového apnoe. Únava znamená pocit nedostatku energie alebo vyčerpania. Pri spavosti ide o sklon zaspať. Obe ťažkosti sa môžu vyskytovať naraz. Keďže sa posudzovali v tom istom období, oslabenie asociácie s eGFR neumožňuje určiť, či únava sprostredkúva vplyv nižšej filtrácie na spavosť [1].

Nespavosť a záťaž príznakmi

Šanca nespavosti stúpala s mierou, v akej pacientov obťažovali kŕče, svrbenie a obavy z ochorenia obličiek. Súvislosti pretrvali aj po zohľadnení ďalších faktorov vrátane depresie a spánkového apnoe. Benzodiazepíny s dlhým eliminačným polčasom sa spájali s dennou spavosťou v čiastočne upravenom modeli. V plne upravenom modeli už táto súvislosť nedosiahla štatistickú významnosť. Výsledky preto podporujú preverenie príznakov a liekov pri vyšetrení. Účinok liečby svrbenia či kŕčov alebo úpravy predpísaných liekov na spánok kohorta nehodnotila [1].

Rozhovor v nefrologickej ambulancii

Pri sťažnosti na zlý spánok sa oplatí rozlíšiť ťažkosti so zaspávaním a udržaním spánku, dennú spavosť a pocit vyčerpania. Pri nespavosti má zmysel spýtať sa, či pacienta v noci budí svrbenie alebo kŕče a či mu bránia zaspať obavy. Pri spavosti treba zistiť, či pacient cez deň nechcene zaspáva, preveriť dĺžku nočného spánku a prejsť užívané lieky vrátane sedatív. Pozorované prestávky v dýchaní počas spánku spolu s dennou spavosťou sú dôvodom posúdiť podozrenie na obštrukčné spánkové apnoe. Samotný dotazník na jeho diagnostiku nestačí. Pri potvrdenej chronickej nespavosti odporúča American Academy of Sleep Medicine viaczložkovú kognitívno-behaviorálnu terapiu nespavosti [1, 2, 3].

Opakované dotazníky umožnili skúmať súvislosti v početnej kohorte. Údaje o príznakoch však vychádzali z výpovedí pacientov, len 44 % pozorovaní obsahovalo všetky údaje a chýbajúce hodnoty autori dopĺňali viacnásobnou imputáciou. Časovú následnosť súvislostí analýza neurčila. Výsledky sa týkajú pacientov sledovaných v nefrologických ambulanciách pred dialýzou [1].

Literatúra

1. *Bénédicte Stengel, Emilie Moutard, Marie Metzger, Isabelle Jaussent, Aghilès Hamroun, Solène M Laville, Abdou Omorou, Denis Fouque, Ziad A Massy, Roberto Pecoits-Filho, Luc Frimat, Natalia Alencar de Pinho, Sophie Liabeuf, CKD-REIN study investigators. Sleep Disturbances in Chronic Kidney Disease - The CKD-REIN Cohort Study. Kidney Med. 2026;8(11):101530.* DOI a vydavateľ · PubMed 42899186 · Plný text
2. *Vishesh K Kapur, Dennis H Auckley, Susmita Chowdhuri, David C Kuhlmann, Reena Mehra, Kannan Ramar, Christopher G Harrod. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504.* DOI a vydavateľ · PubMed 28162150 · Plný text
3. *Jack D Edinger, J Todd Arnedt, Suzanne M Bertisch, Colleen E Carney, John J Harrington, Kenneth L Lichstein, Michael J Sateia, Wendy M Troxel, Eric S Zhou, Uzma Kazmi, Jonathan L Heald, Jennifer L Martin. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2021;17(2):255-262.* DOI a vydavateľ · PubMed 33164742 · Plný text

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nespavost-denna-spavost-ckd-rein · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.